

03-30 Aula: Delirium na UTI — Diagnóstico (CAM-ICU) e Manejo Baseado em Evidências

Delirium na UTI (AMIB/Prova de Título 2026) — reconhecimento, diagnóstico e manejo “do jeito da prova”

1) Conceito e por que a banca cobra tanto

Delirium é uma **disfunção cerebral aguda e flutuante**, definida por **alteração de atenção** (núcleo do diagnóstico), com **alteração do nível de consciência** e/ou **desorganização do pensamento**, tipicamente com **curso flutuante** ao longo do dia.

Na UTI, é um “tema inevitável” porque é **frequente**, **subdiagnosticado** e **impacta desfechos duros**.

Ponto de prova (alta prioridade): delirium é ao mesmo tempo **sintoma** e **marcador de gravidade**.

2) Fenótipos clínicos (pegadinhas clássicas)

Há três apresentações principais:

a) Hiperativo

- **Agitação**, inquietação, agressividade, tentativa de retirar dispositivos
- **Risco de autoextubação** e eventos adversos imediatos
- Mais “visível” → tende a ser diagnosticado

b) Hipoativo****o mais comum e o mais subdiagnosticado

- Paciente “quieto”, sonolento, lentificado, pouco responsivo
- Pode parecer apenas “cansado”, “deprimido”, “sedado” ou “metabolicamente lento”

- Alta chance de passar despercebido → *pegadinha recorrente*

c) Misto

- Alterna entre hipo e hiperatividade

Regra mental útil: *hiperativo chama atenção; hipoativo “some” e por isso “cai” na prova.*

3) Por que importa (desfechos associados)

O delirium na UTI se associa a:

- ↑ Mortalidade
- ↑ Tempo de ventilação mecânica
- ↑ Tempo de UTI/hospital
- Déficit cognitivo a longo prazo (sequelas neurocognitivas pós-UTI)

Mensagem-chave: não é “apenas agitação”; é **lesão cerebral funcional aguda** com repercussão prognóstica.

4) Fatores de risco — organize em “predisponentes” e “precipitantes”

A banca costuma exigir essa lógica.

4.1 Predisponentes (do paciente)

- Idade avançada
- Demência/comprometimento cognitivo prévio
- Comorbidades e fragilidade

4.2 Precipitantes (da UTI/do episódio agudo)

- Hipoxemia
- Distúrbios metabólicos (ex.: disnatremias, uremia, hipoglicemia/hiperglicemia, acidose)
- Infecção/seps
- Privação de sono
- Sedação (destaque para **benzodiazepínicos**)
- Imobilidade, dor mal controlada, abstinência (álcool/sedativos), polifarmácia (anticolinérgicos, opioides em altas doses, etc.)

Flashcard de prova (do seu material):

Qual o principal fator modificável de delirium na UTI?

Sedação inadequada, especialmente com benzodiazepínicos.

5) Diagnóstico à beira-leito (o que você tem que “falar e fazer” na prova prática)

Diagnóstico é **clínico**, mas deve ser **padronizado** com instrumento validado.

5.1 Ferramenta “padrão” na UTI: CAM-ICU

A lógica cobrada é a dos **4 itens**:

1. **Início agudo e curso flutuante**
2. **Desatenção**
3. **Pensamento desorganizado**
4. **Alteração do nível de consciência**

Em geral, delirium é identificado quando há **1 + 2 + (3 ou 4)**.

Armadilha frequente: confundir “sedação” com ausência de delirium. Paciente pode estar **hipoativo** ou **pouco responsivo** e ainda assim delirante; primeiro é preciso garantir **nível de despertar avaliável** e então aplicar ferramenta (na prática, isso se integra ao fluxo com escalas como RASS).

6) Manejo — o que muda prognóstico (e o que não muda)

A abordagem correta é **em camadas**, começando pelo essencial.

6.1 Primeira prioridade: tratar a causa (medicina intensiva raiz)

Procurar e corrigir gatilhos:

- **Hipóxia/hipoventilação**
- **Infecção/seps**
- **Distúrbios metabólicos**
- **Dor, abstinência, retenção urinária, constipação, efeitos adversos de fármacos**

Frase de prova: o tratamento principal do delirium NÃO é remédio; é corrigir causas + prevenção.

6.2 Medidas não farmacológicas (essenciais e “prova-friendly”)

Implementar pacote de prevenção/manejo:

- **Reorientação** (óculos/aparelho auditivo, calendário, presença de família quando possível)
- **Higiene do sono** e preservação do ciclo sono-vigília
 - reduzir **ruído** e **luz** noturna; evitar procedimentos desnecessários de madrugada
- **Mobilização precoce** (quando seguro)
- Reduzir restrições e cateteres desnecessários
- Analgesia adequada (dor é precipitante importante)

6.3 Sedação: menos é mais (e benzo é vilão)

- **Evitar benzodiazepínicos** (associados a maior risco de delirium)
- Preferir estratégias com:
 - **Dexmedetomidina** (útil quando objetivo é sedação leve/cooperativa e facilitação de desmame; contexto de delirium/agitação pode ser favorável)
 - **Propofol** (quando necessário, com metas claras e evitando sedação profunda prolongada)

Ponto de prova: sedação profunda não protege — em geral **aumenta risco** e prolonga VM/UTI.

6.4 Antipsicóticos: para sintomas, não para “curar delirium”

- **Haloperidol** e **quetiapina** podem ser usados para **controle de sintomas** (ex.: agitação perigosa, risco de autoextubação, sofrimento importante, delírios/alucinações com risco)
- **Não reduzem mortalidade** e **não devem ser vistos como terapia modificadora de desfecho** do delirium

Mensagem que a banca gosta: antipsicótico = **contenção farmacológica de sintomas**, enquanto a base é **causa + prevenção + sedação adequada**.

7) Questão AMIB (Questão 40): por que a alternativa B é a correta

B. “O delirium está associado a pior prognóstico, incluindo aumento de mortalidade.”

Correta, pois delirium se associa consistentemente a desfechos piores (mortalidade, tempo de VM e UTI, déficit cognitivo).

Por que as outras alternativas estão erradas (modelo de justificativa “seca” de prova)

- “Benzodiazepínicos reduzem delirium” → **ERRADO**. Benzodiazepínicos tendem a **aumentar** risco (especialmente uso e sedação inadequados).
 - “Só ocorre em idosos” → **ERRADO**. Pode ocorrer **em qualquer idade**; idosos têm maior risco, mas não exclusividade.
 - “Sedação profunda protege” → **ERRADO**. **Sedação profunda** é fator associado a pior evolução e maior risco de delirium.
-

8) Estação prática/conduta: paciente em VM agitado — o que fazer primeiro?

Em prova prática, o “primeiro passo” raramente é “sedar mais” sem avaliar.

Sequência mental segura e defensável:

1. **Garantir segurança imediata** (tubo/linhas, oxigenação, sincronia grosseira)
2. **Avaliar causas reversíveis de agitação**: dor, hipóxia, hipercapnia, obstrução do tubo, secreções, distensão, retenção urinária, abstinência
3. **Checar delirium** (nível de despertar e aplicação de ferramenta como CAM-ICU quando possível)
4. **Ajustar ventilador** se houver assincronia/drive elevado e isso estiver sustentando agitação
5. **Ajustar sedoanalgesia com alvo** (evitar benzo; buscar sedação leve)

Pegadinha: “sedar mais” sem investigar hipóxia/dor/assincronia pode piorar desfecho e mascarar delirium hipoativo depois.

Esquema-resumo (mapa mental + palavras-chave)

- **Delirium = disfunção cerebral aguda + flutuante**
 - núcleo: **desatenção**

- **Tipos:**
 - **Hiperativo** (agitação, autoextubação)
 - **Hipoativo****mais comum e subdiagnosticado**
 - **Misto**
 - **Importância prognóstica:** ↑ mortalidade, ↑ VM, ↑ UTI, déficit cognitivo
 - **Risco:** idade, demência (predisponentes) + hipóxia, sepse, metabólico, **benzo**, privação de sono (precipitantes)
 - **Diagnóstico:** CAM-ICU (1 agudo/flutuante + 2 desatenção + 3 desorganizado ou 4 consciência)
 - **Manejo:**
 - **Tratar causa** (hipóxia, sepse, distúrbios)
 - **Não farmacológico:** reorientação, sono, mobilização, reduzir ruído/luz
 - **Sedação:** evitar **benzodiazepínicos**; metas de sedação leve; considerar **dexmedetomidina/propofol** conforme caso
 - **Antipsicótico:** controle de sintomas, não reduz mortalidade
-

Resumo objetivo com diretrizes e evidências (com respostas às “perguntas” do material)

Respostas diretas alinhadas às recomendações atuais:

- **Delirium piora prognóstico e se associa a maior mortalidade** → **Sim** (evidência observacional robusta; reconhecido em recomendações internacionais).
- **Principal fator modificável: sedação inadequada, especialmente benzodiazepínicos** → **Sim** (diretrizes recomendam minimizar benzo e sedação profunda).
- **Delirium hipoativo é o mais comum e mais subdiagnosticado** → **Sim** (ponto clássico de ensino e prova).
- **Antipsicóticos reduzem mortalidade do delirium** → **Não**; uso é para sintomas e segurança, sem benefício consistente em desfechos duros.

Diretrizes e referências-chave para estudo/revisão (citadas de forma objetiva):

- **PADIS (Society of Critical Care Medicine)** — Diretrizes de manejo de dor, agitação/sedação, delirium, imobilidade e sono em adultos críticos (recomendam **monitorização, estratégias não farmacológicas, evitar**

benzodiazepínicos quando possível e **sedação leve**). *SCCM PADIS Guidelines, 2018.*

- **ABCDEF bundle** (implementação de pacote: analgesia, despertar/respiração, escolha de sedação, delirium monitorização, mobilidade, família) associado a melhores desfechos clínicos em estudos de implementação. *Evidência de bundles e melhoria de desfechos em UTI (literatura de implementação do ABCDEF, anos 2010+).*
- **Evidência sobre antipsicóticos:** ensaios clínicos e revisões não demonstram redução consistente de mortalidade/duração de delirium; permanecem como opção para **controle de agitação perigosa**. *(Ensaaios multicêntricos e revisões sistemáticas em delirium de UTI, 2010s–2020s).*

Se você quiser, eu transformo isso numa **estação prática completa** (roteiro de 5–7 minutos) com: **RASS → CAM-ICU**, diferenciação de **dor vs assincronia vs abstinência vs hipóxia**, e uma **prescrição modelo** de sedoanalgesia alinhada às metas.